

RAIVA — LAVAR, CLASSIFICAR, VACINAR/SORO

CLASSIFICAÇÃO DA EXPOSIÇÃO E CONDUTA

Tipo de contato	Exemplo	Conduta
Sem exposição	Tocar/alimentar animal, lambertura em pele íntegra	Lavar; NÃO indicar profilaxia
Leve (acidente leve)	Arranhão/mordedura superficial em tronco/membros; lambertura em pele com lesão	Lavar + vacina (esquema) conforme avaliação do animal
Grave (acidente grave)	Mordedura em cabeça/face/pescoço/mãos/pés, múltiplas/profundas, lambertura de mucosa, morcego	Lavar + vacina + IMUNOGLOBULINA antirrábica
Morcego (qualquer contato)	Qualquer contato com morcego, mesmo sem ferida evidente	Sempre considerar exposição GRAVE -> vacina + soro
Animal de risco	Cão/gato com sinais, animais silvestres, raposa, sagui	Tratar como potencial transmissor

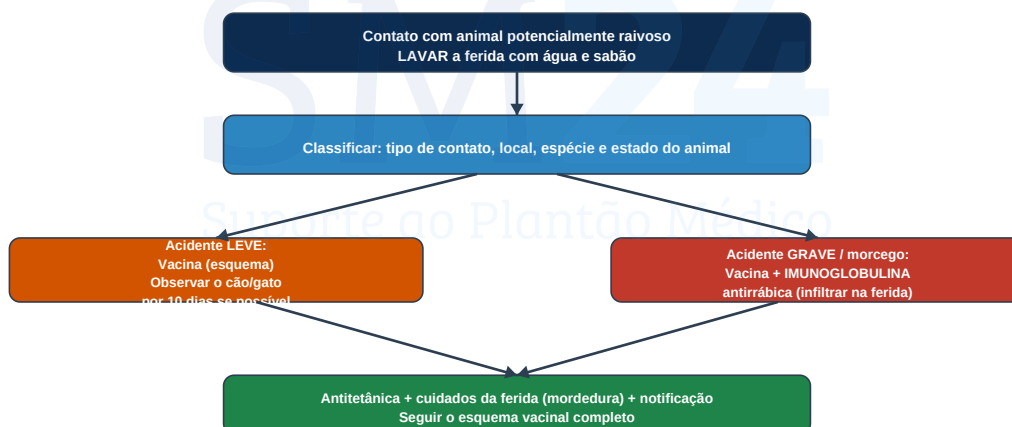
PRIMEIRA MEDIDA SEMPRE: LAVAR A FERIDA

RAIVA TEM LETALIDADE PRÓXIMA DE 100% — A PROFILAXIA É QUASE SEMPRE EFICAZ

- Lavar a ferida imediatamente com água e sabão em abundância (reduz a carga viral) — medida mais importante no local
- Não suturar a ferida se possível; se necessário, fazer pontos amplos após infiltrar a imunoglobulina
- Classificar a exposição (leve x grave) e avaliar o animal agressor e a região
- A raiva, instalada a doença, é praticamente sempre fatal — por isso a profilaxia é uma urgência
- Atualizar a profilaxia antitetânica e avaliar antibiótico para a ferida (mordedura)
- Notificação compulsória do acidente por animal potencialmente transmissor

DECISÃO PÓS-EXPOSIÇÃO

MORDEDURA/CONTATO -> LAVAR -> CLASSIFICAR



VACINA, IMUNOGLOBULINA E OBSERVAÇÃO DO ANIMAL

Componente	Detalhe
Vacina (cultura celular)	Esquema de pós-exposição em múltiplas doses (D0, D3, D7 e D14, conforme protocolo do serviço/Ministério da Saúde)
Imunoglobulina antirrábica	Nos acidentes graves: infiltrar o máximo possível ao redor da ferida; o restante IM em local distante da vacina
Soro heterólogo x imunoglobulina humana	Usar a disponível conforme o serviço; atenção a reações no soro heterólogo (equino)
Observação do cão/gato	Animal sadio observável por 10 dias: pode-se individualizar/interromper o esquema se permanecer sadio
Animais silvestres/morcego	Não há observação confiável -> profilaxia completa (grave)
Pré-exposição	Para profissionais de risco (veterinários, espeleólogos) — esquema diferente

SITUAÇÕES ESPECIAIS

Animal e Região

- Cabeça, face, pescoço, mãos e pés: maior risco (rica inervação) = acidente grave
- Morcego: qualquer contato é grave (mordida pode passar despercebida)
- Cão/gato observável e sadio: permite individualizar a conduta
- Animais silvestres (sagui, raposa, guaxinim): tratar como grave
- Lamedura de mucosa ou pele lesada: exposição relevante
- Roedores urbanos (rato, camundongo): risco muito baixo

Cuidados da Ferida por Mordedura

- Lavar abundantemente; evitar sutura primária quando possível
- Avaliar antibiótico (amoxicilina-clavulanato) para mordeduras de risco
- Atualizar a profilaxia antitetânica
- Imunoglobulina antirrábica infiltrada na ferida nos casos graves
- Orientar sinais de infecção e retorno
- Notificar o acidente

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Lavar a ferida imediatamente com água e sabão — primeira e principal medida local
- ☐ Classificar a exposição (leve x grave) considerando local, espécie e estado do animal
- ☐ Acidente grave / qualquer contato com morcego: vacina + imunoglobulina antirrábica
- ☐ Imunoglobulina infiltrada ao redor da ferida; restante IM distante da vacina
- ☐ Cão/gato sadio observável por 10 dias permite individualizar o esquema
- ☐ Atualizar antitetânica, avaliar antibiótico da mordedura e notificar

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com mordedura profunda em mão por cão desconhecido. Qual a conduta de profilaxia antirrábica?

- A) Apenas lavar a ferida
- B) Lavar + vacina + imunoglobulina antirrábica (acidente grave, em região de risco)
- C) Apenas vacina, sem imunoglobulina
- D) Observação domiciliar sem profilaxia
- E) Antibiótico isolado

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual a primeira e mais importante medida LOCAL após uma mordedura de risco para raiva?

- A) Suturar a ferida imediatamente
- B) Lavar abundantemente com água e sabão
- C) Aplicar apenas antisséptico alcoólico
- D) Cauterizar a ferida
- E) Imobilizar o membro

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Paciente relata contato com morcego dentro de casa, sem ferida evidente. Qual a conduta?

- A) Nenhuma profilaxia, pois não há ferida visível
- B) Considerar exposição GRAVE e indicar vacina + imunoglobulina antirrábica
- C) Apenas observar o paciente
- D) Somente atualizar a antitetânica
- E) Vacina apenas se surgirem sintomas

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Sobre a imunoglobulina antirrábica, qual afirmação é correta?

- A) Deve ser administrada apenas por via oral
- B) Deve-se infiltrar o máximo possível ao redor da ferida, aplicando o restante IM em local distante da vacina
- C) Substitui a vacina nos acidentes graves
- D) É indicada em todos os acidentes leves
- E) Deve ser aplicada no mesmo local da vacina

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Mordedura por cão domiciliado, aparentemente sadio, que pode ser observado. Qual a conduta possível?

- A) Profilaxia completa obrigatória sempre, sem observação
- B) Iniciar a conduta conforme a gravidade e individualizar/observar o animal por 10 dias, podendo ajustar o esquema se permanecer sadio
- C) Nenhuma conduta é necessária
- D) Apenas antibiótico
- E) Imunoglobulina isolada sem vacina

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Mordedura profunda em mão (região de risco) por cão desconhecido é acidente GRAVE: requer lavagem abundante + vacina + imunoglobulina antirrábica (infiltrada ao redor da ferida). Atualizar antitetânica e avaliar antibiótico para a mordedura.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A lavagem imediata e abundante da ferida com água e sabão é a primeira e mais importante medida local — reduz a carga viral no sítio da inoculação e diminui o risco de raiva.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Qualquer contato com morcego deve ser considerado exposição GRAVE (a mordida pode ser imperceptível), indicando vacina + imunoglobulina antirrábica, mesmo sem ferida evidente.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A imunoglobulina antirrábica deve ser infiltrada o máximo possível ao redor/dentro da ferida, e o restante aplicado por via IM em local distante da vacina (para não neutralizar a resposta vacinal). Ela complementa, não substitui, a vacina.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Quando o cão/gato é domiciliado e pode ser observado por 10 dias, é possível individualizar a conduta: inicia-se conforme a gravidade e, se o animal permanecer sadio durante a observação, o esquema pode ser ajustado/interrompido conforme o protocolo.

SM24
Suporte ao Plantão Médico